

Información Paciente

Nombre : Ruth Eliana Fuentes Méndez **Rut** : 11.491.557-2 **N° Archivo** : 2210583
Edad : 56a 4m 10d **Fecha Nacto**: 06/12/1968 **Sexo** : Femenino
Dirección : Nuevo Continente 3723 Andes Del Sur **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 977556931

N° Epicrisis
437625

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Ginecología (4° Piso) **Fecha Ingreso** : 16/04/2025 06:50 **Días Estadía** : 1
Unidad de Egreso : Ginecología (4° Piso) **Fecha Egreso** : 16/04/2025 12:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Ingresa de forma electiva para cono LEEP.

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES GENERALES

- AM: Hipertensión pulmonar leve en control anual, HTA, obesidad, inmunosupresión, TEPT, TOC
- Qx: trasplante hepático por cirrosis autoinme (2023), 1 cesárea
- Alergias (-)
- Medicamentos: Tacrolimus, elcalD, fluoxetina, losartan, amlodipino
- TBQ: (-)
- Familiares: (-)

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

- G-O: FO 20102 1CCA, 2PV (óbito fetal de término por PES).
- Menopausia: 51 años.
- TRH nunca.
- PAP 2024 ASC-H.
- Mamografía Dic 2024 BIRADS 3

HISTORIA ONCOLÓGICA

Paciente derivada por PAP (13/5/24): ASCUS y PAP (30/11/24): ASC-H.

Evaluada en oncoginecología Colposcopia (24/1/2025): ZT2, sin lesiones EAB. CEC.

Biopsia: epitelio exocervical con signos sugerentes de NIEAG.

Se indica Cono LEEP de forma electiva.

ACTUALMENTE

Paciente con antecedentes descritos ingresa de forma electiva para cono LEEP.
Test pack (-)

LABORATORIO DE INGRESO:

26/03/25: Alb: 4.2, BT: 1.20, BD: 0.35, FA: 121, GGT: 106, GOT: 24, GPT: 20, Crea: 1.25, Glucosa: 76, LDH: 178, Hto: 42.4, Hb: 14.1, Leuco: 7.85, Plt: 220, TP: 13.5, TTPA: 32.8

Fecha Epicrisis : 16/04/2025 12:29

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 16-04-2025 12:29:37

Página 2 de 3

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

M3 (1 CCA)
NIEAG

EVOLUCIÓN:

El día 16/04/25 se realiza cono LEEP sin incidentes, se envía muestra a biopsia diferida.
Paciente evoluciona en BCG, Hd estable. Con dolor bien tolerado con analgesia, deambulando sin inconvenientes. Diuresis espontánea. En condiciones de alta y seguimiento ambulatorio.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

M3 (1 CCA)
NIEAG
P/O CONO LEEP 16/04/25.

Dr. Rojas - Residente Ginecología
Dr. Valdés - Dr. Ávalos - Residentes Ginecología Oncológica
Dr. Puga - Jefe Unidad Ginecología Oncológica HSR
Equipo Ginecología Oncológica HSR

Diagnóstico de Egreso

DISPLASIA DEL CUELLO DEL UTERO, NO ESPECIFICADA -

Condición de Egreso

Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable. Con dolor bien tolerado con analgesia, deambulando sin inconvenientes. Diuresis espontánea. En condiciones de alta y seguimiento ambulatorio.

Plan Post Alta

Reposo relativo
Régimen común
Abstinencia sexual por 6 semanas
Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos c/8 horas VO por 5 días
Ketoprofeno 50 mg, 1 comprimido c/8 horas VO por 3 días
Mantener medicamentos de uso habitual
Rescatar resultado de biopsia en 4-6 semanas en anatomía patológica
Pedir hora de control en oncoginecología (CDT pasillo 7) para 6 semanas con resultado de biopsia.
Reconsultar en el Servicio de Urgencias SOS en caso de: sangrado genital abundante, dolor abdominal, flujo genital de mal olor, fiebre o cuando estime necesario.

Dr. Rojas - Residente Ginecología
Dr. Valdés - Dr. Ávalos - Residentes Ginecología Oncológica
Dr. Puga - Jefe Unidad Ginecología Oncológica HSR
Equipo Ginecología Oncológica HSR

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 16/04/2025 12:29

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 16-04-2025 12:29:37

Página 3 de 3

INTERNO

Luis Alexander Rojas Cedeño

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 16/04/2025 12:29

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:29

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar